

TEMA 8.10 • NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA

Polineuropatías, Neuralgias y Neuropatías por Atrapamiento

PERFIL EUNACOM 1.10.1.013

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndromes Motores: Miastenia, Guillain-Barré y Mielitis Transversa

Miastenia Gravis vs. Lambert-Eaton

TABLA 8.10.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	MIASTENIA GRAVIS	SÍNDROME LAMBERT-EATON
Anticuerpos	Anti-receptor nicotínico ACh (placa motora)	Anti-canales de Ca ²⁺ presinápticos
Debilidad con repetición	Empeora	Mejora (se "calienta")
SN autónomo	No afecta	Sí (miosis, disfunción esfínteres)
Tumor asociado	Timoma	Ca. pulmón células pequeñas
Clínica ocular	Ptosis + diplopía (músculo extensor del ojo)	Ptosis + diplopía

- Miastenia Gravis: diagnóstico con **test edrofonio (tensilon)** + EMG + anti-AChR - Tratamiento de timoma → cirugía puede curar la miastenia

Síndrome de Guillain-Barré (SGB)

- **Causa:** desmielinización del **SNP** (≠ EM que afecta SNC)
- **Desencadenante:** infección previa (más frecuente: diarrea por **Campylobacter jejuni**)
- También puede ser post-viral (COVID-19, CMV) o post-vacunal (muy raro)

Clínica típica

- **Tetraparesia flácida arreflexica** (ascendente, progresiva) → síndrome de 2ª motoneurona
- Hipostesia + dolor en extremidades
- **Parálisis facial bilateral** (VII par) — muy característico
- Riesgo de parálisis frénica → **insuficiencia respiratoria** (vigilar CVF)

Exámenes de apoyo

TABLA 8.10.2: EXAMEN VS HALLAZGO	
EXAMEN	HALLAZGO
EMG	Reducción de velocidad de conducción en todo el nervio
Punción lumbar	Disociación albúmino-citológica (↑proteínas, células normales)

Tratamiento

- Soporte ventilatorio (si CVF < 15 mL/kg)
- **Plasmaféresis o Inmunoglobulina G en alta dosis** (ambas equivalentes)
- **No corticoides** (no sirven en GBS)

Variante: Síndrome de Miller-Fisher

- GBS + afectación de **múltiples pares craneales** (oftalmoplejia, ataxia, arreflexia)
- No confundir con miastenia gravis (fluctuante crónica ≠ progresivo agudo)

Diagnósticos diferenciales

TABLA 8.10.3: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS	
DIFERENCIA	
Botulismo	Solo motor; lactante < 1 año + miel; afecta varios simultáneamente
Poliomielitis	Erradicada; solo en inmunodeprimido post-vacuna oral
Mielitis transversa	Nivel sensitivo + compromiso esfínteres + dolor dorsal

Mielitis Transversa

- **Causa:** autoinmune (LES, Sjögren)
- **Clínica:** síndrome de sección medular desde el nivel afectado hacia abajo:
 - - Paraparesia o tetraparesia (síndrome piramidal → al inicio puede ser flácido)
- - **Nivel sensitivo** claro (clave diagnóstica)
- - Compromiso de esfínteres (vejiga, recto)
- - Dolor dorsal
- **Diagnóstico:** RNM médula espinal
- **Tratamiento:** corticoides EV

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente diabético de 65 años consulta por sensación de quemazón y hormigueo en ambos pies, que ha aumentado progresivamente. Al examen presenta disminución de la sensibilidad termalgésica en ambos pies y tobillos. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más importante?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Polineuropatías, Neuralgias y Neuropatías por Atrapamiento. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Polineuropatía diabética: la más frecuente. Disminución de sensibilidad en guante y calcetín, predominio distal. Tratar causa + cuidar pies.
- Dolor neuropático: urente, alodinia (dolor con estímulo no doloroso) e hiperalgesia (dolor excesivo con estímulo doloroso).
- Neuralgias: primaria (examen normal → carbamazepina) vs secundaria (examen alterado → neuroimagen). Dolor eléctrico/en ramalazo.
- Neuralgia postherpética: prevenir con aciclovir/valaciclovir en primeras 48h del herpes zóster.
- Neuropatías por atrapamiento: parestesias + paresias siguiendo un nervio. Estudio: electromiografía. Tratamiento: cirugía.
- Túnel carpiano (mediano): dedos 1-4. Cubital: dedos 4-5. Meralgia parestésica (femorocutáneo): muslo lateral, asociada a obesidad.
- Parálisis del borracho: compresión del nervio radial → no extiende muñeca/dedos. Parálisis de luna de miel: compresión del plexo braquial.
- Diferencia: miopatías = debilidad proximal sin atrofia. Polineuropatías = debilidad distal con atrofia + síntomas sensitivos.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (POLINEUROPATÍAS, NEURALGIAS Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO)**PREGUNTA 1**

Paciente diabético de 65 años consulta por sensación de quemazón y hormigueo en ambos pies, que ha aumentado progresivamente. Al examen presenta disminución de la sensibilidad termalgésica en ambos pies y tobillos. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más importante?

- A)** Neuropatía por atrapamiento; solicitar electromiografía
- B)** Polineuropatía diabética; control metabólico y cuidado de los pies
- C)** Neuralgia postherpética; iniciar carbamazepina
- D)** Síndrome de Guillain-Barré; hospitalizar
- E)** Miopatía diabética; solicitar CPK

PREGUNTA 2

Paciente de 45 años, secretaria, consulta por hormigueo y debilidad en los primeros 3 dedos de la mano derecha de meses de evolución. ¿Cuál es el estudio de elección y el tratamiento definitivo?

- A)** Resonancia magnética cervical; descompresión quirúrgica cervical
- B)** Electromiografía; cirugía de liberación del túnel carpiano
- C)** TAC de cerebro; anticonvulsivantes
- D)** Radiografía de muñeca; inmovilización con férula
- E)** Electromiografía; carbamazepina

PREGUNTA 3

Paciente de 30 años amanece con imposibilidad de extender la muñeca y los dedos de la mano derecha después de haberse quedado dormido en una fiesta apoyado sobre su brazo. ¿Cuál es el nervio afectado?

- A)** Nervio mediano
- B)** Nervio cubital
- C)** Nervio radial
- D)** Plexo braquial
- E)** Nervio musculocutáneo

RESUMEN: POLINEUROPATÍAS, NEURALGIAS Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

Esta clase cubre los síndromes sensitivos: polineuropatías, neuralgias y neuropatías por atrapamiento, más algunos cuadros raros como la parálisis del borracho y la parálisis de la luna de miel. Las polineuropatías afectan múltiples nervios, siendo la diabética la más frecuente. La clínica incluye disminución de sensibilidad (termalgésica, vibratoria, propioceptiva), de distribución distal en guante y calcetín, posible debilidad distal, y dolor neuropático (urente, alodinia, hiperalgesia). El tratamiento es tratar la causa y cuidar los pies (prevención de pie diabético). Las neuralgias se caracterizan por dolor eléctrico/en ramalazo que sigue la distribución de un nervio. Las principales son: trigémino, Arnold, postherpética y glossofaríngeo. Se dividen en primarias (examen neurológico normal, se tratan con carbamazepina) y secundarias (examen alterado, requieren neuroimagen). La neuralgia postherpética se previene con aciclovir/valaciclovir en las primeras 48 horas del herpes zóster. Las neuropatías por atrapamiento presentan parestesias, paresias y alteración de reflejos siguiendo un nervio. Se estudian con electromiografía y se tratan con cirugía. Las principales son: túnel carpiano (mediano, dedos 1-4), atrapamiento cubital (dedos 4-5) y meralgia parestésica (femorocutáneo lateral, cara lateral del muslo, asociada a obesidad). La parálisis del borracho afecta el nervio radial y la de la luna de miel afecta el plexo braquial.